ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 – SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL
Telefone: (83) 99144-2153 / Horário de Atendimento: 07h às 13h, Segunda à Sexta, Cartório Unificado da Fazenda Pública de João Pessoa (PB)

SENTENÇA

PROCESSO Nº 0801957-44.2024.8.15.0171

Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por **HELANNE REGINA VALENTIM LIMA** em face do **ESTADO DA PARAÍBA.**

Em resumo, aduz que é portadora de **câncer de mama – CID C50** e alega que faz jus ao recebimento do seguinte medicamento ***"VERZENIOS (ABAMACICLIBE) 150mg – 01 comprimido ao dia, por 24 (vinte e quatro meses)"*** para tratamento oncológico.

Juntou laudo médico apontando a sua enfermidade (id. 102309405) e negativa administrativa, conforme ids. 102309406 e 104803914.

Juntada aos autos nota técnica emitida pelo NATJUS para o caso concreto (id. 106033558).

Foi concedida a antecipação de tutela de urgência (id. 106549547).

O ESTADO DA PARAÍBA ofereceu resposta. Em sede preliminar suscitou a preliminar de falta de interesse processual em virtude da possibilidade de substituição do tratamento médico pleiteado por outro já disponibilizado pelo Estado.

No mérito argumentou que a necessidade de observância dos requisitos estabelecidos pelos temas de repercussão geral nº 06 e 1234, bem como das súmulas vinculantes 60 e 61 do STF, bem como dos temas 06 do STF e 106 do

STJ; a ausência de prova do fato constitutivo do direito da parte e da existência de fato impeditivo; a necessidade da elaboração de parecer de lavra do NATJUS; a inexistência de direito à escolha do medicamento; a necessidade de observância do preço máximo de venda ao governo – PMVG no cumprimento da decisão judicial; da apreciação equitativa dos honorários advocatícios; e, por fim, da obrigatoriedade de ressarcimento administrativo por parte da União na eventualidade de condenação do Estado.

É o breve relatório. Decido.

Tenho que o feito comporta o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, I, do CPC, eis que não há necessidade de produção de outras provas além das já acostadas aos autos.

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243 (Tema 1234), editou a súmula vinculante nº 60, com a seguinte redação:

> *"O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)".*

Por sua vez, no referido Recurso Extraordinário, quanto à legitimidade da parte e competência do juízo, **relativamente aos tratamentos oncológicos**, foram firmadas as seguintes teses

> *"tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC".*
>
> *"4.2) Medicamento não incorporado (incluindo oncológico) cujo tratamento anual custe igual ou mais de 210 salários mínimos: competência da Justiça Federal e responsabilidade integral da*

União, com posterior ressarcimento integral ao Estado, caso este venha a arcar com o tratamento".

Ainda quanto à competência e legitimidade houve a modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

> *"Quanto a estes processos e unicamente quanto à competência jurisdicional, para que não haja qualquer prejuízo às partes, mais notadamente os milhares de cidadãos brasileiros que ajuizaram ações em foros competentes, de acordo com a cautelar firmada por mim e ratificada pelo Plenário do STF, tenho que, diante das dramáticas situações de saúde e de vida presentes em cada demanda e, considerando os posicionamentos recentes do STF sobre a consequência do julgamento pelo STF em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade, tenho que os efeitos dos acordos, unicamente quanto à modificação de competência (item 1, caput, da tese a seguir proposto), somente incidirão sobre os processos ajuizados após a publicação da ata deste julgamento. Dito de outro modo: serão atingidos, unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial no STF), pelo resultado do julgamento de mérito deste recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral, apenas os processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento. Consequentemente, os feitos ajuizados até tal marco deverão atender os efeitos da cautelar deferida nestes autos e homologada pelo Plenário do STF, mantendo-se onde estiverem tramitando sem deslocamento de competência (sendo vedado suscitar conflito negativo de competência entre órgãos jurisdicionais de competência federal e estadual, reciprocamente), todavia, aplicando-se imediatamente todos os demais itens dos acordos. Diante desse cenário, apesar de homologar, em parte, os exatos termos dos acordos – e apenas para que não pairem dúvidas de que se trata de modulação unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1) –, proponho que esta somente se aplique aos feitos que forem ajuizados após a publicação da ata do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, de sorte a afastar sua incidência quanto aos processos em tramitação até o referido marco".*

A ata de julgamento do RE nº 1.366.243 foi publicada em 19/09/2024.

Desse modo, compete a este juízo processar e julgar esta demanda, não havendo que se falar em incompetência ou ilegitimidade passiva do Estado da Paraíba.

2. DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDA PELO ESTADO DA PARAÍBA

Do ponto de vista técnico a condição da ação interesse processual possui três vertentes.

O interesse necessidade, utilidade e adequação.

No caso dos autos, partido da narrativa exordial (teoria da asserção), tem-se que o interesse necessidade está presente, na medida em que se narrou a omissão estatal no dever de prestar o bem da vida pretendido.

O interesse utilidade é evidente, eis que o provimento jurisdicional pretendido (fornecimento do medicamento) se mostra útil para a parte substituída, posto que é a forma de se tratar a sua enfermidade.

Por fim, o meio eleito é claramente o adequado.

De mais a mais, bem se vê que o(s) demandado(s) resistem à pretensão, o que revela uma pretensão resistida e, portanto, a presença da apontada condição da ação.

Assim, deve ser rejeitada essa preliminar.

4. DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO

Inicialmente é de bom tom registrar que em relação aos tratamentos oncológicos no âmbito do SUS, devido ao sistema diferenciado de financiamento dos procedimentos e tratamentos, o fornecimento de fármacos não se restringe às tecnologias incorporadas ou não - **ao contrário do que ocorre para as demais enfermidades** - mas sim, ao que pode ser oferecido ao paciente, considerando o financiamento repassado aos centros de atenção pelo Ministério da Saúde, observando-se a autonomia dos médicos dos CACONS/UNACONS na escolha da melhor opção terapêutica.

Por outro prisma, na área da oncologia o Sistema Único de Saúde pública as denominadas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) em oncologia que *"são documentos baseados em evidência científica que visam nortear as melhores condutas na área da Oncologia. A principal diferença em relação aos PCDT é que, por conta do sistema diferenciado de financiamento dos procedimentos e tratamentos em oncologia, este documento não se restringe às tecnologias incorporadas no SUS, mas sim, ao que pode ser oferecido a este paciente,*

considerando o financiamento repassado aos centros de atenção e a autonomia destes na escolha da melhor opção para cada situação clínica". (In: https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas/ddt (https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-saude/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas/ddt)).

A paciente foi diagnosticada **com câncer de mama – CID C50**, conforme se extrai do laudo acostado no id. 102309405:

LAUDO MÉDICO

A Sra Helanne Regina Valentim Lima, 46 anos, é portadora de neoplasia de mama direita – cT3N1M0 – EIIIA. RE: 95% RP: 85% HER2: - KI67: 80% . Lesão inicial palpável +- 8 x 6 cm, endurecida, com pele em peau d'orange.

Submetida a tratamento neoadjuvante com Ontax 160mg semanalmente (D1, D8, D15) por 4 ciclos e posteriormente, Fauldoxo 120mg associado a Genuxal 1200mg a cada 15 dias por 4 ciclos. Realizou procedimento cirúrgico em mama direita mantendo neoplasia residual, IAL+ e linfonodo comprometido, mostrando uma resposta parcial ao tratamento efetuado. ypT1cN1

Devido paciente manter um alto risco de recidiva com linfonodo comprometido, doença com alto volume (8cm), ki67: 80%, idade 44 anos, não ter tido resposta completa com o tratamento neoadjuvante, tem indicação de iniciar tratamento com hormonioterapia de primeira linha com inibidor de quinase dependente de ciclina 4/6 (Abemaciclibe) por 24 meses, associado a inibidor de aromatase (Letrozol). Além disso, devido pré menopausa se faz necessário ablação ovariana com Zoladex 3,6mg 28/28 dias e pelo uso da hormonioterapia, também tem indicação de ácido zoledrônico (Zometa) 6/6 meses. A indicação do uso de inibidor de osteólise, deve-se ao benefício de diminuição do risco de fraturas patológicas ósseas e preservação mineral, secundariamente, diminuindo mortalidade decorrente de evento ósseo.

O estudo MonarchE [J Clin Oncol 38:3987, 2020 e atualização em Ann Oncol 32:1571, 2021) mostrou um seguimento mediano de 27,1 meses, o HR para ILDI se manteve robusto e altamente significativo (HR atual de 0,70; p<0,0001 versus HR anterior de 0,75 com 15,5 meses de seguimento) [Ann Oncol 32:1571, 2021]. Com base nesses dados, a ANVISA e o FDA aprovaram o uso de abemaciclibe na adjuvância, estando a indicação na bula da medicação.

A paciente iniciou o uso de letrozol associado a zoladex e zometa desde janeiro/2023, porem necessita associar Abamaciclibe (Verzenios) 150 mg, 01 cp, VO, de 12/12h, continuamente por 24 meses.

Sem mais,

A parte requerente vem realizando o seu tratamento no CPO - Centro de Oncologia e Hematologia de Campina Grande, que é um centro privado destinado ao tratamento oncológico, não integrando o Sistema Único de Saúde.

Entrementes, ressalto que, após a leitura do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Câncer de Mama, verifico que a **Portaria SCTIE/MS nº 73/2021** determinou a incorporação dos medicamentos **Abemaciclibe,** Palbociclibe e Succinato de Ribociclibe para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com receptor hormonal positivo e HER2 negativo. Veja-se:

Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde

PORTARIA SCTIE/MS Nº 73, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021

Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde.

Ref.: 25000.112928/2021-08, 0023990518.

O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde.

Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto nº 7.646/2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS.

Art. 3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essas tecnologias estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLIO ANGOTTI NETO

Não obstante, impende salientar que as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 1366243 (Tema 1234) e 566.471 (Tema 6), não se destinam aos tratamentos oncológicos, embora, na ótica deste julgador, o deferimento do pedido pressuponha a demonstração dos seguintes requisitos: existência de recusa administrativa; impossibilidade ou ineficácia do uso dos medicamentos e tratamentos existentes nas DDTs do SUS, caso existente; e demonstração, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco postulado.

Fixadas essas premissas, tenho que o caso é de acolhimento da pretensão, eis que os requisitos acima foram preenchidos.

Tanto o é que a nota técnica indicou que existem evidências científicas acerca da eficácia do fármaco para o tratamento da enfermidade, tendo emitido parecer favorável:

> **Tecnologia:** ABEMACICLIBE
>
> **Conclusão Justificada: Favorável**
>
> **Conclusão:** Considerando a solicitação de acesso ao medicamento abemaciclibe para o tratamento de câncer de mama HER2-negativo e receptor hormonal positivo (RH+), eu me posiciono favoravelmente à sua disponibilização, em conformidade com as recomendações da CONITEC.
>
> O abemaciclibe, quando combinado com terapia endócrina, tem mostrado benefícios claros, como o aumento da sobrevida livre de progressão e sobrevida global, além de uma melhora

significativa na qualidade de vida dos pacientes com câncer de mama avançado ou metastático. Diversos estudos clínicos demonstram que essa combinação é eficaz e bem tolerada, representando uma opção valiosa para pacientes com esse perfil de câncer.

A CONITEC, após análise das evidências científicas, recomendou a incorporação do abemaciclibe ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de câncer de mama avançado ou metastático RH+ e HER2-negativo. Essa recomendação leva em conta não apenas a eficácia do medicamento, mas também sua boa relação custo-benefício e o impacto positivo no controle da doença. Portanto, acredito que a disponibilização do abemaciclibe para a paciente é plenamente justificada, alinhando-se às diretrizes do SUS e às necessidades clínicas específicas da requerente.

Por fim, extrai-se dos autos que a parte autora buscou receber o tratamento administrativamente, mas não obteve sucesso, consoante id. 101624056.

Ainda, no que concerne a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, entendo que os argumentos da Procuradoria do Estado não devem ser acolhidos, uma vez que: (i) "nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos" (NCPC, art. 85, § 3º, inciso I); (ii) o valor atribuído à causa (R$ 96.000,00) correspondente ao valor anual do tratamento (proveito econômico obtido), em atendimento ao disposto no art. 292, § 2º, do NCPC: "O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações"; e (iii) não houve, na contestação impugnação ao valor atribuído à causa, tratando-se de matéria preclusa (NCPC, art. 293).

Em assim sendo, entendo que a pretensão autoral deve ser acolhida.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, julgo procedente o pedido contido na inicial, confirmando a liminar concedida, para determinar que a parte ré forneça à paciente *"VERZENIOS (ABAMACICLIBE) 150mg – 01 comprimido ao dia, por 24 (vinte e quatro*

***meses)”*; incluindo-a em serviço ou programa já existentes no SUS, de responsabilidade de quaisquer das entidades federativas, sob pena de sequestro do dinheiro necessário à sua aquisição.**

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando a verba em 10% do valor atualizado da causa.

O ente público fica isento do pagamento das custas, a teor do disposto no artigo 29 da Lei Estadual 5.672/92.

Deixo de determinar a remessa necessária, pois, não obstante a aparente iliquidez da condenação (STJ, Súmula 490), o valor total ou anual (prestações de uso contínuo) do tratamento perseguido não alcançará valor superior ao teto estabelecido pelo artigo 496, § 3º, do NCPC, razão pela qual está dispensado o duplo grau de jurisdição obrigatório.[2]

Destarte, a remessa destes autos e de inúmeros outros similares ao Egrégio TJPB por força de remessa necessária representaria uma **sobrecarga imotivada de trabalho ao tribunal *ad quem***, sendo certo que inexiste nulidade sem prejuízo para a parte interessada (NCPC, art. 282, § 1º), a exemplo do que ocorre nos presente autos, em que, repita-se, o valor total ou anual (prestações de uso contínuo) do tratamento perseguido é inferior ao teto estabelecido pelo artigo 496, § 3º, do NCPC, podendo a parte ré submeter a análise da demanda ao Egrégio TJPB através da interposição de recurso apelatório.

Sentença publicada e registrada com a inserção no sistema PJE.

Intimem-se as partes.

Se houver a interposição de recurso de apelação:

1. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões à apelação, num prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 1.010, § 1º).

2. Se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões, em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 1.010, § 2º).

3. Após as formalidades acima mencionadas, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba (NCPC, art. 1.010, § 3º).

Com o trânsito em julgado, se nada for requerido (NCPC, art. 523), arquive-se.

João Pessoa/PB, datado e assinado eletronicamente.

Luiz Gonzaga Pereira de Melo Filho

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: LUIZ GONZAGA PEREIRA DE MELO FILHO
23/04/2025 09:17:17
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 111312831

25042309171715200000100

IMPRIMIR GERAR PDF